

督导专题包·危机处理与转介指南

谁需要这份文档: 所有使用本套件的情感咨询师 + 督导核心问题: 危机发生了怎么办? 转介怎么做? 使用方式: 出现危机前熟悉流程; 出现危机中严格执行; 危机后复盘

一、危机的”定义”与”分类”

1.1 什么是”危机”(Crisis)

咨询中的”危机”,指的是任何可能危及来访者、咨询师、或他人生命/安全的紧急情况。

危机与”问题”的区别: - 问题 = 可等待处理 (例: 来访者”反复怀疑”) - 危机 = 不可等待立即处理 (例: 来访者”今天要死”)

1.2 危机的”4类”

类别 1: 来访者的”自杀风险”

- 最常见的危机
- 包括: 自杀念头/计划/尝试

类别 2: 来访者的”他杀/暴力风险”

- 包括: 对他人的攻击/暴力/威胁
- 包括: 对家庭成员/伴侣/孩子的暴力
- 包括: 对咨询师的威胁/攻击

类别 3: 来访者的”急性精神状况”

- 包括: 急性解离 / 急性精神病发作
- 包括: 严重抑郁 / 严重焦虑发作
- 包括: 物质滥用导致的急性中毒/戒断

类别 4: 咨询师/督导/机构的”伦理”问题

- 包括: 咨询师的严重耗竭 / 精神问题
- 包括: 咨询师的伦理违规
- 包括: 督导的自身问题

1.3 危机的”紧迫性”评估

任何危机, 都需要立即评估紧迫性:

紧迫性	含义	行动
极高 (24 小时内)	来访者即将实施自杀/他杀	立即干预 (见 3.1)
高 (1 周内)	来访者有强烈的自杀/他杀念头, 但还没确定计划	24-48 小时内干预

紧迫性	含义	行动
中 (1 月内)	来访者有反复的自杀/他杀念头, 但没计划	1-2 周内干预
低 (评估中)	来访者有模糊的自杀/他杀念头, 但不清晰	2-4 周内干预

二、危机处理的”6 个核心原则”

原则 1: 安全第一 (Safety First)

任何危机处理, 最重要的是”安全”: - 来访者的安全 - 他人的安全 - 咨询师自己的安全 - 督导自己的安全

永远: 安全 > 任何其他考虑 (包括治疗关系、保密、咨询师的”治疗理念”等)

原则 2: 不要”单打独斗”

任何危机, 不是”咨询师一个人”能处理的: - 立即寻求督导 - 必要时联系精神科/医院 - 必要时联系家属 (在来访者同意下, 或紧急情况) - 必要时联系警察 (在紧急情况)

原则 3: 不要”轻看”危机

咨询师最危险的错误是”轻看危机”: - “她只是说说, 不会真做” - “他只是威胁, 不会真做” - “她只是情绪, 不会真做”

所有的自杀/他杀念头, 都应该被认真对待。所有的”只是说说” / “只是情绪”, 都可能是“最后一次求助”。

原则 4: 不”诊断”, 只”评估”

危机处理不是”诊断” —是 “评估” 与”处理”。

- 不是”她是不是抑郁症” —是 “她的自杀风险多高”
- 不是”他是不是反社会人格” —是 “他会不会实施暴力”
- 不是”咨询师有没有精神问题” —是 “他能不能继续执业”

原则 5: 来访者的”知情同意”与”伦理”

危机处理中, 伦理与”知情同意”仍然重要, 但: - 当安全危险, 可突破保密 (例如: 联系家属/医院/警察) - 当突破保密时, 必须: - 尽可能先通知来访者 (“我要联系你的家属/医院”) - 记录理由、过程、结果 - 事后与来访者讨论 (“我为什么这样做”)

原则 6: 危机处理后, 必须”复盘”

危机处理完后, 必须: - 个人复盘 - 督导复盘 - 必要时机构复盘 - 未来预防计划

三、自杀风险的”评估”与”处理”

3.1 立即自杀风险 (24 小时内) 的处理

如果来访者透露: 现在就要自杀:

第 1 步: 立即评估 (2-5 分钟) - “你有没有 ‘现在就要死’ 的念头?” - “你有没有 ‘计划怎么做’?” - “你有没有 ‘什么时候做’?” - “你有没有 ‘什么地点做’?”

第 2 步: 保持在场 (不要离开) - 不要挂断电话 - 不要让来访者单独 - 保持对话 - 保持冷静、温暖、支持的声音

第 3 步: 承诺与联系 - “你愿意和我承诺, 这 24 小时不实施吗?” - “你愿意让我联系你的家属吗?” - “你愿意去医院吗?”

第 4 步: 寻求帮助 - 立即联系督导 (事前有督导的紧急联系方式) - 立即联系精神科/危机干预中心 - 必要时联系 110 / 当地危机热线

第 5 步: 记录与跟进 - 详细记录危机处理过程 - 危机后 24-48 小时跟进

3.2 高自杀风险 (1 周内) 的处理

如果来访者透露: 这周有自杀念头, 但没明确计划与时间:

第 1 步: 详细评估 (15-30 分钟) - 详细评估自杀风险 (见 3.4) - 包括: 念头/计划/手段/时间/地点/过去尝试/支持系统/保护因素

第 2 步: 安全计划 - “这周, 你能做什么让自己安全的事?” - “如果念头又出现, 你能联系谁?” - “你能承诺这周不实施吗?”

第 3 步: 支持系统 - “你的家人/朋友/精神科/医院, 谁能支持你?” - “建议联系精神科/危机热线” - “建议告知一个可信任的家人/朋友”

第 4 步: 增加咨询频率 - 从周 1 次 → 周 2-3 次 - 必要时电话/视频中的 “check-in”

第 5 步: 与督导讨论 - 事件中讨论 - 整个危机处理后详细复盘

第 6 步: 与精神科合作 - 必要时转介 - 建立密切联系

3.3 中/低自杀风险的处理

中风险: 1 月内的念头, 没计划 - 增加咨询频率 - 讨论保护因素与支持系统 - 与督导讨论 - 可考虑精神科评估

低风险: 模糊念头, 不清晰 - 正常咨询节奏中关注 - 评估保护因素 - 不必立即干预

3.4 自杀风险评估的”标准问题”

当你需要评估来访者的自杀风险 (任何时候有念头就应该评估):

1. 念头

- “你有 ‘想死’ 的念头吗?”
- “你这念头是 ‘经常’ 还是 ‘偶尔’?”

2. 计划

- “你有 没有 计划怎么 做?”
- “你有 没有 想过 ‘方法’?”

3. 手段

- “你有 没有 ‘手段’?(例: 药/绳/枪)”

4. 时间

- “你什 么时 候 打算 做?”

5. 地点

- “你有 没有 选定地 点?”

6. 过去尝试

- "你以前有没有实施过?"

7. 保护因素

- "还有什么让你不做的?"
- "家人/朋友/信仰的作用?"

8. 支持系统

- "你有谁能帮你?"
- "你有没有联系精神科/医院的计划?"

3.5 自杀风险“分级”的“标准”

风险等级	标准	干预
极高	有明确的计划/手段/时间	立即干预 (住院/陪同)
高	有反复念头 + 部分计划	24-48 小时内干预
中	有反复念头 + 没计划	1-2 周内精神科评估
低	有偶尔念头 + 没计划	正常咨询中关注
无	没念头 + 没计划	正常咨询

3.6 自杀风险评估的“红线”

以下任一, 都是“极高风险”: - 有明确的自杀计划 - 有获取手段的能力 - 有选定时间/地点 - 有过去实施自杀的历史 - 有强烈的孤独感 - 有物质滥用加重风险

四、他杀/暴力风险的“评估”与“处理”

4.1 立即暴力风险 (24 小时内) 的处理

如果来访者透露: 现在就要实施暴力 (包括: 对他人/对咨询师):

第 1 步: 保持自身安全 - 不要激怒来访者 - 不要独自面对 (有必要叫同事/警卫) - 保持距离

第 2 步: 评估风险 - “对象是谁?” - “有没有武器?” - “什么时候打算做?”

第 3 步: 报警 (如必要) - 若风险极高, 立即报警 (110) - 告知警察: 具体信息 (地点/对象/手段)

第 4 步: 及时通知潜在受害者 - 如受害者是家人/伴侣, 联系他们 (在可能的情况下) - 告知他们风险, 建议立即离开/求助

第 5 步: 记录与督导 - 详细记录 - 立即联系督导 - 可考虑停止咨询

4.2 暴力/虐待史的处理

当来访者透露过去的暴力/虐待史 (不是立即风险):

- 认真听, 不要过度反应
- 评估对来访者的长期影响
- 评估是否有“目前的危害者”

- 考虑转介精神科 + 治疗 (复合性 PTSD)
- 督导讨论

4.3 暴力/虐待预防与长期工作

对于有暴力/虐待史的来访者: - 慢慢建立安全感 (不是立即反复讨论创伤) - 慢慢帮他理解”这不是我的错” (尤其对虐待的内化) - 帮助他重新获得”控制感” - 转介其他资源 (精神科/家庭暴力支持中心)

五、急性精神状况的”评估”与”处理”

5.1 急性解离的处理

症状: 来访者”不在” (失现实感/失自我感):

- 保持冷静
- 地接技术 (5-4-3-2-1 感官扫描):
 - “5 件你看到的东西”
 - “4 件你听到的声音”
 - “3 件你触到的触感”
 - “2 件你闻到的气味”
 - “1 件你尝到的味道”
- 重复这些步骤, 直到来访者”回来”
- 如长时间解离, 立即联系精神科

5.2 严重焦虑发作/恐慌发作的处理

- 保持冷静
- 指导来访者慢慢呼吸 (4-7-8 技术)
- 帮助他”着地” (感官接触)
- 如反复发作, 建议精神科评估
- 考虑焦虑障碍的长期治疗 (CBT/SSRI)

5.3 急性精神病发作的处理

症状: 幻觉/妄想/思维紊乱/严重脱离现实:

- 保持冷静
- 不要争论他的幻觉/妄想 (不是争论能解决的)
- 立即联系精神科 (要求紧急评估)
- 如必要, 联系家属/陪同就医
- 停止咨询 (精神病期间咨询无效)
- 督导讨论

5.4 物质中毒/戒断的处理

- 评估中毒/戒断的严重程度
- 如严重, 立即就医
- 如戒断症状, 建议专业脱瘾治疗
- 不要单独管理中毒/戒断的来访者
- 督导讨论

六、咨询师/督导/机构的”伦理”危机

6.1 咨询师的自身危机

当咨询师出现: - 严重耗竭 (见《耗竭识别与恢复》) - 精神问题 (严重抑郁/精神病/自杀念头) - 物质滥用 - 伦理违规 (与来访者发生关系/泄露信息/私下联系)

处理流程:

第 1 步: 识别 (咨询师自己/督导/同僚) 第 2 步: 立即介入 (督导/上级/精神科) 第 3 步: 评估是否能继续执业第 4 步: 如不能: 停止执业, 转介其他咨询师第 5 步: 如涉及伦理: 上报专业机构第 6 步: 长期治疗 + 复评第 7 步: 复评通过后, 逐步恢复执业

6.2 督导的自身危机

当督导出现: - 不能维持专业判断 - 自身出现耗竭/精神问题 - 与咨询师发生不适当关系 - 伦理违规

处理流程: 同上 (咨询师的危机处理), 但要报告上级督导/专业机构

6.3 机构的危机

当机构出现: - 大规模伦理事件 - 咨询师多人出现危机 - 媒体关注的危机 - 法律诉讼

处理流程: - 立即成立危机处理小组 - 外部资源介入 (律师/媒体关系/精神科) - 公开承诺处理 - 保护来访者与咨询师 - 长期改进

七、转介的”实操流程”

7.1 什么时候应该转介

转介的常见原因: - 咨询师出现严重反移情 (灵魂伴侣/反复触发) - 来访者出现危机 (自杀/他杀/急性精神病) - 来访者超出咨询师能力 (严重精神病/反社会/强烈暴力) - 来访者要求转介 - 治疗进展不良 (长期无进步) - 来访者与咨询师的”配对”不合适 (性别/年龄/文化/特定主题) - 治疗阶段变化 (从个人咨询转伴侣咨询)

7.2 转介的”标准流程”

第 1 步: 评估与决策 - 明确转介的原因 - 与来访者讨论 - 与督导讨论 - 评估接受方 (谁接介?)

第 2 步: 明确转介的时机与方式 - 当面告知 (最推荐) 或电话 - 在结束前 2-3 次给来访者准备时间 - 不突然结束

第 3 步: 处理来访者的反应 - 倾听来访者的反应 (伤心/愤怒/理解) - 承认转介的”失落感” - 反复保证: “我不是不在意你” - 强调: 这是”专业”决策, 不是”个人”拒绝

第 4 步: 实际转介 - 联系接受方咨询师 - 提供简要的接介文件 (脱敏的案例概要) - 确认接介细节 - 告知来访者接介信息

第 5 步: 结束与跟进 - 正式结束 - 处理来访者的”分离焦虑” - 必要时: 与接介方咨询师沟通 - 咨询师自己的复盘

7.3 转介时的”伦理”事项

- 保密: 不透露来访者的身份/敏感信息 (除必要的临床信息)
- 知情同意: 获取来访者的明示同意
- 接介文件: 简要的脱敏的案例概要 (不是详细记录)
- 权利保护: 来访者有权拒绝转介

7.4 接介文件模板

转介文件

=====

一、基本信息

来访者编号/化名: ____

性别/年龄: ____

主诉: ____

二、依恋与九型

依恋象限: ____

九型主型: ____

健康层级: ____

三、当前阶段

评估 看见模式 哀悼重建 新经验 维护

已工作次数: ____

关键进展: ____

四、当前议题

需要继续工作的: ____

紧急议题: ____

五、特殊情况

自杀风险: ____

暴力风险: ____

物质使用: ____

急性精神状况: ____

其他: ____

六、推荐理由

七、接收方建议

转介者: -----
日期: -----

八、危机处理的”团队”准备

8.1 机构/个人必备的”危机资源库”

联系方式 (放在容易找到的地方, 如手机、办公桌):

危机资源

=====

紧急联系电话

110 (警察)

120 (急救)

119 (消防)

精神/心理危机热线

[当地心理危机干预中心]

[全国心理援助热线]

[当地精神卫生中心]

转介资源

[3-5 名精神/心理同行, 可以转介]

[3-5 名精神科医生]

[3-5 名咨询师督导]

[1-2 名律师]

专业机构

[当地心理协会]

[当地咨询师行业协会]

8.2 个人危机准备

每个咨询师应该: - 身上携带危机联系方式 - 在办公桌放资源清单 - 与督导确定危机联系方式 - 定期更新资源清单 - 演练危机处理 (模拟场景)

8.3 机构危机准备

机构应该: - 有危机处理手册 - 有危机干预小组 - 定期危机演练 - 与精神卫生中心建立合作 - 与律师建立合作

九、危机处理后的”复盘”流程

9.1 个人复盘

危机处理后 24-48 小时内: - 记录危机处理的全过程 - 评估你的反应 (是否冷静、是否遵循流程)
- 评估你的情绪反应 - 记录学到的教训

9.2 督导复盘

危机处理后 1 周内: - 与督导详细讨论整个危机处理过程 - 评估你的决策 - 讨论可以改进的地方
- 讨论你的反移情/未完成议题 - 如必要: 进入个人咨询

9.3 机构复盘

危机处理后 1 月内 (如果严重): - 机构内部复盘 - 更新危机处理手册 - 更新资源清单 - 培训所有咨询师 - 必要时外部评估

十、给咨询师的”红线”

10.1 咨询师绝对不能做的事

- 不要对来访者的自杀念头轻看
- 不要对来访者的暴力倾向忽略
- 不要单独处理危机
- 不要在危机中“治疗”——先安全, 再治疗
- 不要瞒报伦理问题
- 不要继续执业当你自己有严重问题

10.2 咨询师必须做的事

- 必须熟悉危机评估工具
 - 必须有危机资源清单
 - 必须知道如何联系精神科/医院
 - 必须有督导/同行的危机联系
 - 必须有个人咨询
 - 必须定期培训危机处理
-

十一、最后的提醒

危机处理的”三个核心”：1. 安全第一 2. 不要单独行动 3. 不要轻看危机

危机处理的”三个禁忌”：1. 不要轻看 2. 不要瞒报 3. 不要瞒骗 (来访者的家属/精神科)

愿你熟悉危机流程, 在危机发生时能有序有效地处理。愿你有强大的支持网络, 在危机中不孤单。

版本: v1.0 日期: 2026-07-17 作者: Mavis

配套资源: - 督导专题包-主文档.md - 督导专题包-督导流程与记录模板.md - 督导专题包-12个构型的督导要点.md - 督导专题包-危机处理与转介指南.md(本文档)